

Et donc on va faire une pratique sur, déjà, l'observation simplement de la gaine dural coronale, par rapport à la symphyse, et par rapport simplement, cette fois-ci, au maxillaire. On va simplement aller voir comment ces champs vont se poser, mais là, il faudra vous mettre sur un niveau électrique. Et c'est comme ça qu'on soigne aussi les tendons, les tendinites. Vous pouvez changer plein de choses, tant que vous n'avez pas remis les courants électriques, ça ne passera pas. Et quand on voit cette mise en place de la base du crâne, c'est le neurocrâne par rapport au viscérocrâne. C'est comme si tout ton système viscéral était soutenu à la base du crâne, comme une gorge. Et en haut, j'ai mon cerveau, qui est le neurocrâne. Et entre les deux, j'ai ça. Et puis, j'ai ça. Je ne sais pas aller directement sur cette base du crâne. Par contre, je peux y arriver par la périphérie, puisqu'on sait que toutes mes membranes durmériennes de tension viennent tous s'attacher à ma base du crâne. Elles sont comme un marais. Je vais d'abord prendre ma suture coronale, et je vais prendre la partie ici qu'on appelle le maxillaire. Je me mets sur ce niveau-là, maxillo-zygomatique, en fait. Et je vais être là. Et là, j'ai aussi une gaine qui fait ça. Et qui vient aussi, en fait, c'est une ligne qui vient aussi vers la base du crâne. C'est comme des anneaux. Les deux anneaux doivent se rencontrer et doivent être en connexion, si tu veux, tu vois. Et le niveau électrique, c'est un niveau subtil où c'est comme si c'est on ou off, en fait. N'oubliez pas, cette suture coronale est assez basse, parce qu'il y en a beaucoup qui sont là. On va aller assez bien sur cette suture coronale, là où il y avait Bregma. Parce que si c'est vivant, c'est qu'il y a des échanges thermiques. Il y a une chaleur quand même qui s'impacte. Elle peut sentir aussi, doucement. Il y a un point un peu sur la ligne où il y a une petite perte d'énergie. Là, ce que tu sens là maintenant, je vais te faire sentir, je vais mettre sur la fréquence électrique. Là, je me mets sur cet anneau. Là, j'ai cette connexion, je vais vers cette symphyse,

phénobésilée. Donc ici, je peux déjà dire, tiens voilà, c'est vital, c'est chaud, ça répond. Il y a quand même un petit travail qui va se faire dans ce mouvement ici, on va voir. Je vais me mettre maintenant en connexion avec la partie de son maxillo-osigomatique ici, comme ceci, qui vient aussi vers, c'est comme si ces deux anneaux se rencontrent en fait. Voilà, donc déjà entre les deux, il y a une différence. Il y a déjà une perte quand même un peu au niveau en haut, donc il y a quand même une fatigue, il y a une lutte. Là, tout de suite, je suis sur ces surrénales. Un petit chou ici, il y a un rapport surrénalien direct. Donc ici, il faut un peu recharger les batteries chez madame. Donc par exemple ici, quand je suis là et que je ressens ça en consulte, tout de suite, je me mets sur ces surrénales et je réchauffe les surrénales. Je libère les ligaments ici et je me mettrai comme ceci. Pour recharger mes surrénales. Après, on fera la relation avec tout le système cardiaque, donc tout le système endothélial. Comment on peut travailler sur le caractère. Il y a quatre portes d'entrée qui sont carotides internes gauche et droite et vertébrales gauche et droite, puis système basilaire. basilaire. Avec comment ils sont réactifs si on les touche correctement, qu'on peut les libérer par rapport au cœur. ou parfois par rapport même au système vitellin ombilical, donc mésaréique ou spénique, sur le sinus du cœur. Moi, je travaille avec quatre énergies, avec l'énergie de la pesanteur, de la gravité, pour redonner un juste contact. Soit il y a des gens trop lourds, ils sont déjà enterrés. Soit il y a des gens, ils sont même trop légers, ils flottent. Puis l'énergie de la ligne médiane, puis l'énergie du corps énergétique pur. Ici, on est plus sur ce plan électrique. Ça, ce qu'on ressent, c'est vibratoire. Et ici, de nouveau, coronal. J'attends, puis je vais revoir ici. Ici, de nouveau, voilà, j'ai déjà plus de vitalité. Ce n'est pas encore à 100%, mais c'est déjà mieux. Là, il y avait un vide, tu vois. Donc, c'est le hamac de l'œil. Voilà, tu vois, il y avait un strain, tout l'axe supérieur. Donc, tout qui était en strain, voilà, là, ça serait qui ? –

Sous-titrage ST' 501 C'est comme si ça faisait un j'exagère, mais c'était comme ça. Quand j'ai reconnu le tissu, il a son point de référence. Il y a l'induction, il y a le mouvement en facilité. Je ne suis pas dans le mouvement en facilité, je suis dans la présence. Premier niveau. Deuxième niveau, je vais travailler canineau, maxillo, trois doigts, au niveau de ma bosse frontale. J'ai un axe comme ça. Il faut que j'ai des bons points d'appui, sinon ma main va être en déséquilibre. Là, je sens de nouveau, si je sens cette chaleur et cette vibration, c'est bien dans le plan. Je cherche bien ma bosse frontale, qui est ici. Je reste ici. Maintenant, je suis ici. Là, je prends en même temps la ligne ici et en même temps la ligne ici. Tu vois ? La ligne zygomatico-bosse frontale homolatérale. Donc comme ça, j'ai deux niveaux. Ici, j'ai une bonne chaleur, j'ai un bon champ. Ici, c'est plus diminué. Je vais aller voir ici le niveau de la suture coronale. Je vais palper ma suture coronale. Là, c'est assez... Voilà, ici, tout petit peu. Tu sens là ? Voilà, ici. Parfois, ça fait clouks. Canino, maxilo, ici, frontale, et comme ça. Voilà, ça passe. Ce n'est pas comme je voudrais à droite. Comme je voudrais comme... Ici, de l'autre côté. Canino, canine. Frontale, ici, départ. Et puis, ici et là. Il y a vraiment ici, cet axe ici qui est perturbé. Donc, il y a une perte d'énergie ici. Peut-être que c'est plus lent, tu vois, pour travailler. C'est pour ça que ça va guérir plus vite. Donc, ici, ce que j'ai chaque fois retrouvé, c'est chaque fois une... Perte un peu de vitalité, entre guillemets. Et un peu sur la suture coronale. Que je n'avais pas... Enfin, que j'avais un petit peu au départ, qui était occupée à chercher. Donc, c'est occupé à se rééquilibrer comme ça. Troisième niveau, qu'on fait maintenant. Relancement de la flexion. Qu'elle a un mastoïde, qu'elle a une petite torsion comme ça. Donc, il y en a un un peu plus antérieur que l'autre, si tu veux. Je vais voir si c'est un point de changement et de balance. Et là, je peux aller en induction ou en mouvement facilité. Ici, c'est une technique de légère induction. Je suis son extension. Hop, elle part en

flexion. Et j'accompagne sa flexion. Quand je me mets dans ces choses-là, ici, j'observe sa respiration. Et si je veux aller dans un point de changement, j'observe son activité expiratoire. Parfois, les gens, ils font une... Qu'est-ce que c'est que ça ? C'est un changement de polarité. inspiration et un grand souffle donc ils font une oxydation un changement d'oxydoréduction.